

伤寒论条文解读

条文卡片合集 PDF

条文数量

20 条

资料定位

中医条文学习资料

本次包含

1-20条

说明：本资料内容为学习胡希恕和李冠杰老师体系心得，如有表述欠妥处，与李冠杰老师无关，是作者学习和领会不足所致。更全面的体系知识推荐大家学习胡希恕老师和李冠杰老师的《康平本伤寒论讲稿》和《金匱要略讲稿》。**声明：**以下内容仅是学习资料整理，不构成任何医学建议。

条文目录

点击任意条文，可直接跳转到对应卡片 · 目录 1/1

条文格式： 1 顶格 2 降一格 3 降两格

1	第1条	太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。
1	第2条	太阳病，发热汗出恶风，脉缓者，名为中风。
1	第3条	太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。
3	第4条	伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。
3	第5条	伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。
1	第6条	太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，...
3	第7条	病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳者，七日愈；发于阴者，六日愈；以阳数七、阴数六故也。
3	第8条	太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行尽其经故也；若欲作再经者，针足阳明使经不传则愈。
3	第9条	太阳病，欲解时，从巳至未上。
3	第10条	风家表解，而不了了者，十二日愈。
2	第11条	病人身大热，反欲得衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。
1	第12条	太阳中风，脉阳浮而阴弱，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。
1	第13条	太阳病，头痛发热，汗出恶风者，桂枝汤主之。
1	第14条	太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。
1	第15条	太阳病下之后，其气上冲者，可与桂枝汤；若不上冲者，不可与之。
1	第16条	太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病。桂枝不中与之也，观其脉证，知犯何逆，随证治之。
3	第17条	酒客病，不可与桂枝汤，得汤则呕，以酒客不喜甘故也。
2	第18条	喘家，作桂枝汤，加厚朴杏子佳。
2	第19条	又服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。
1	第20条	太阳病，发汗遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。



第1条

1 太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

词语解析

- **太阳病**：不是某一个固定病名，而是凡见**脉浮、头项强痛、恶寒**这一组表证反应，都可归入太阳病范围。
- **脉浮**：潜在动脉高度**充血**，血中**水分增多**
- **头项强痛**：太阳病时人体为了从体表排邪，大量体液和血液趋向体表，形成浅表充血，而且**越往上部越明显**
- **恶寒**：体表温度升高，**空气温差骤然变大**，会感觉外面空气很冷

要点总结

第1条是**太阳病总纲**。

核心证候：脉浮、头项强痛、恶寒。

病理抓手：病在表，正气趋表，欲汗不得汗。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲太阳病，重点不把它看成某个固定病名，而看成**人体在表的一种抗病反应**。外邪来时，机体先把**抗病力量调到体表**，**血液、水分也趋向体表**，所以见脉浮。

头项强痛，**上半身、头项部充血较重**；恶寒，体表温度升高，与外界**温差增大**。胡老也常提醒，太阳病只是总纲，具体治疗还要继续分中风、伤寒、温病，以及有汗无汗、发热轻重、脉缓脉紧等，不可见太阳病三字就固定用一个方。

李冠杰讲解

李冠杰老师把第1条视为**太阳病总纲**，它**不是讲现代医学某一个病**，而是给后面所有太阳病条文定范围。

这一条最重要的三个抓手是**脉浮、头项强痛、恶寒**。

学习时要把第1条和第2、第3条连起来看：第1条定太阳病范围，第2条分出中风，第3条分出伤寒，后面桂枝汤、麻黄汤等方证都从这里展开。



第2条

① 太阳病，**发热汗出恶风，脉缓者**，名为**中风**。

词语解析

- **中风**：这里的中风不是卒中，而是太阳病中的一类表虚证，核心是**发热、汗出、恶风、脉缓**。
- **汗出**：**不是大汗出，而是潮乎乎的汗**，出了汗，但达不到驱逐疾病的效果
- **恶风**：汗后体表疏松、湿润，风一吹，散热加快，因此格外怕风
- **脉缓**：缓和紧相对（用烟卷类比，**烟多则紧，烟少则缓**），脉缓的原因是，汗出了**水分丧失了一部分**

要点总结

第2条提出太阳中风。

辨证核心：**发热、汗出、恶风、脉缓**。

与伤寒区别：**中风偏表虚有汗，伤寒偏表实无汗**。

恶寒：没有风吹也怕冷；恶风：风吹怕冷加重

胡希恕讲解

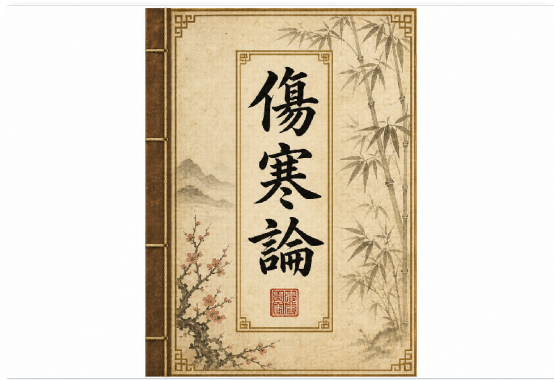
胡希恕老师讲中风，不是现代所谓脑卒中，而是太阳病里**表虚有汗**的一类。发热和汗出并见，说明人体已经有向外排邪的趋势，但卫外不固，汗出而表仍不解；

这一条为后面的桂枝汤证作铺垫。胡老辨桂枝汤，不是单看发热，而是看**汗出、恶风、脉缓弱、表虚营卫不和**这一组反应。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲这里的“中风”不能望文生义成脑血管病，而要回到条文本身。本条重点是**发热、汗出、恶风、脉缓**。它和第3条伤寒正好相对：中风有汗、脉缓，伤寒多无汗、体痛、脉紧。

本条就是太阳中风的主干，后面第12、13条桂枝汤证是对它的展开。



第3条

1 太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。

词语解析

- 伤寒：指表实证。核心是恶寒重、体痛、呕逆、脉紧。
- 或已发热，或未发热：发热可已出现，也可暂未出现，但恶寒是太阳伤寒的标志症状。
- 体痛：大量体液、血液被输送到体表，微细血管高度充盈，压迫身体组织和神经，于是出现体痛。
- 呕逆：全身毛孔闭塞后，气不得向外疏散，便循消化道上逆，形成想吐、呕逆
- 脉阴阳俱紧：体液、血液把血管充得饱满，按下去就显得紧而有力

要点总结

第3条提出太阳伤寒。

发热可有可无，但恶寒是必见的

核心抓手：必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧。

与第2条区别：第2条偏汗出脉缓，第3条偏无汗脉紧。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲太阳伤寒，核心是表实无汗、寒束于表。发热可有可无，但恶寒是必见的，因为表闭未开，正邪相争在表。

体痛说明表闭较重，经脉、肌肉气血不利；呕逆是表证较重时影响胃气上逆；脉阴阳俱紧，则是寒邪束表、津液不得外达的脉象。

胡老会把本条和第2条对读：第2条是桂枝汤方向，第3条是麻黄汤方向。临床不能只看“太阳病”，还要看有汗无汗、脉缓脉紧、身痛轻重。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲原文用“或已发热，或未发热”提醒我们，发热不是最硬的判断点。真正必须抓住的是必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧。尤其“必恶寒”说明只要表证未解，恶寒就很关键。

“伤寒”只是这组症状反应的名称，不是说患者一定受到外界寒邪侵袭，也不是某条经络发生病变。

第3条界定的是太阳伤寒证型，还不能直接与麻黄汤方证完全画等号；具体使用麻黄汤，还要继续结合第35条的无汗、身疼腰痛、骨节疼痛、喘等完整方证。病人不会完全按照书本上的固定症状组合发病，仍须综合判断。



第4条

3 伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。

词语解析

- 一日太阳受之：传与不传，唯一标准是**症状反应**
- 脉若静：脉不特别大、不特别快，病势相对平静，提示**病轻，暂不向内发展**。
- 颇欲吐：不是微微恶心，而是**很想吐**，提示有向少阳柴胡证方向发展的趋势。
- 躁烦、脉数急：烦躁、脉快而急，说明病势在进展，要警惕**传变风险**。

要点总结

第4条讨论伤寒初起的传与不传，唯一标准是**症状反应**。

不传抓手：**脉若静**。

欲传抓手：**颇欲吐、躁烦、脉数急**。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲传与不传，不主张死按一日太阳、二日阳明、三日少阳这样的机械传经。关键仍是**观察脉证变化**。

脉若静，说明病势平稳，暂时没有向内发展的证据；如果出现颇欲吐、躁烦、脉数急，说明病势活动起来，可能转向少阳、阳明或其它阶段。

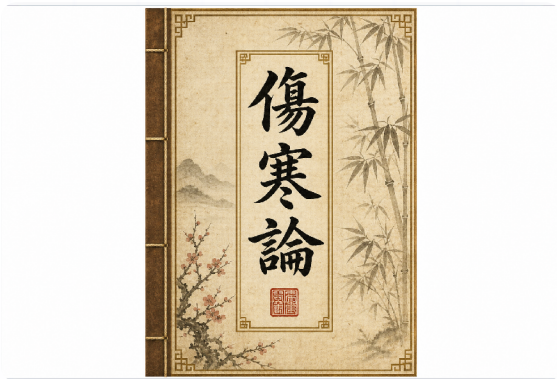
胡老的思路是：**不要用日期决定治疗，而要看当前有没有新的方证**。传不传，不在日数，而在欲吐、躁烦、脉数急等**实际证候**。

李冠杰讲解

李冠杰老师指出不是太阳病主纲，而是对伤寒初起病势变化的说明。

本条最有用的是把“静”和“动”分开看：**脉若静者，为不传**，是病势暂平；**颇欲吐、躁烦、脉数急**，是向内或向其它证转化的苗头。

学习时不要把“伤寒一日，太阳受之”读成固定流程。李冠杰更强调：这是给临床观察病势的一个方法，**仍然要以证候为准**。



第5条

3 伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。

词语解析

- 二三日：只是观察病势变化的时间窗口，不可按日数机械判定传经。
- 阳明证不见：未见里热、口渴汗出、胃家实、腹满便硬等阳明方向证据。
- 少阳证不见：未见往来寒热、胸胁苦满、心烦喜呕、口苦咽干等少阳方向证据。
- 为不传：没有新证据就不能预设传变，仍应按现有脉证辨治。

要点总结

- 第5条承接第4条，继续判断传与不传。
- 核心标准：阳明、少阳证不见者，为不传也。
- 临床原则：按现有脉证辨治，不按日数预设传变。

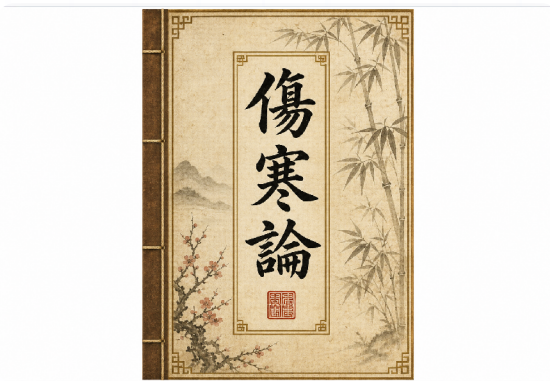
胡希恕讲解

胡希恕老师讲第5条，仍是反对机械传经。二三日只是病程中的观察点，不能说到了二三日就一定传阳明、少阳。
真正要看的，是有没有阳明里热、胃家实、少阳半表半里这些具体表现。若阳明、少阳证不见，就说明病势没有向这些方向发展。
所以本条的临床精神是：不要用日期决定治疗，要用当前证候决定治疗。传不传，不在日数，而在证据。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第5条为降两字格，标三级。它承接第4条，继续说明传与不传不是按日期硬算。
“阳明、少阳证不见”是本条主眼：没有口渴汗出、胃家实、往来寒热、胸胁苦满、喜呕等证据，就不能说已经传入阳明或少阳。
学习时要抓住一句话：见证才算，不见证不算。这是防止套六经流程的关键。

第6条



- 1

太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。
- 2

若发汗已，身灼热者，名风温。
- 1

风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。
- 2

若被下者，小便不利，直视失溲；若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘈瘲；若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。

词语解析

- 温病：温病不属于太阳病，与太阳病的明显区别：“不恶寒，渴”
- 发热而渴：渴是内热的表现，像阳明病白虎汤证也是
- 风温：温病误汗后热势更盛，见身灼热、自汗出，说明汗法伤津助热。
- 自汗出、身重、多眠睡：热盛津伤、正气受困，出现身重嗜睡、鼻鼾、语言难出等重象。
- 误下误火：温热病误下、误火，可见小便不利、直视失溲、发黄、惊痫、瘈瘲，为危重变证。
- 不恶寒：里热太甚，大过温差带来的恶寒感，所以不怕冷

要点总结

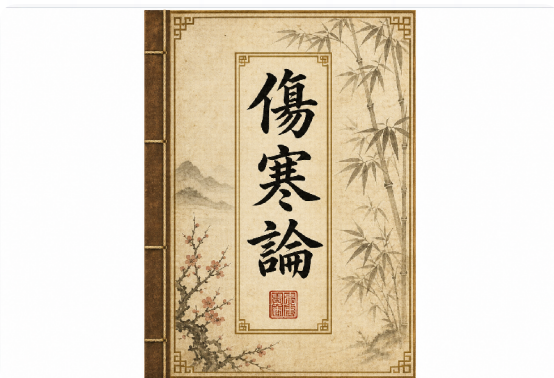
- 第6条要分段看：温病、风温、风温为病、误治变证。
- 温病抓手：发热而渴，不恶寒。
- 治疗边界：不可按太阳伤寒、中风随便发汗。
- 误治风险：汗、下、火法皆可促成危候。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第6条，重点是把温病、风温同普通太阳中风、伤寒分开。它虽然写“太阳病”，但抓手是发热而渴，不恶寒，说明病性偏温热，津液已受影响。若误发汗，热势更盛，出现身灼热、自汗出、身重、多眠睡、鼻鼾、语言难出，这已不是一般表证。后半反复讲误下、误火、火熏的危害，是提醒医者：温热病不可误用汗、下、火法，必须先辨病性，再定治法。

李冠杰讲解

李冠杰老师特别注意第6条的康平本排版：本条内部有顶格、降一字格，卡片中应分段看等级，而不是把长条文一概当成同一层。第一段以发热而渴，不恶寒定温病主眼；第二段讲误汗后身灼热为风温；第三段列风温重证；第四段讲误治危候。学习本条最重要的是：温病不是太阳伤寒、中风，误汗误下误火都可能加重。



第7条

3 病有**发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也**。发于阳者，七日愈；发于阴者，六日愈；以阳数七、阴数六故也。

词语解析

- **发热恶寒**：发热与恶寒并见，说明正气抗邪较有力，多从**阳性表证**方向理解。
- **无热恶寒**：只恶寒而不发热，提示机能沉衰、阳气不足，要警惕**阴证、少阴或里虚寒**。
- **发于阳、发于阴**：不是固定病名，而是根据**发热有无和整体机能状态**判断阴阳属性。
- **七日、六日愈**：属于古人病程与术数解释，临床可参考，**不能代替辨证**。

要点总结

- 第7条区分**发于阳、发于阴**。
- 阳性抓手：**发热恶寒**。
- 阴性抓手：**无热恶寒**。
- 六七日只是病程参考，**不能替代脉证辨证**。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第7条，会把重点放在阴阳属性上。**发热恶寒**，说明人体抗病机能较亢奋，多属阳性病；**无热恶寒**，则阳气不足、机能沉衰的意味更重。
“七日愈、六日愈”只是古人对病程的概括，不能当成绝对日程。
本条实用点是：**不要只看恶寒两个字就判太阳病**，还要看有没有发热、脉象强弱、精神饮食等整体虚实。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第7条为**降两字格**，标三级。它不是太阳病主纲，而是说明发病阴阳属性与病程倾向。
“发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”是本条核心。发热代表正气抗邪仍有力量，无热而恶寒则提示机能不足。
阳数七、阴数六可作传统解释了解，临床仍要抓**发热与否、恶寒性质、整体虚实**。



第8条

3 太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行尽其经故也；若欲作再经者，针足阳明使经不传则愈。

词语解析

- **头痛至七日以上自愈**：说明有些太阳病随着正气恢复可以自解，**不是所有太阳病都必然传变**。
- **行尽其经**：按经脉运行解释病程，学习时可懂其意，**不可机械套时间**。
- **欲作再经**：病势似有继续转向的苗头，要观察是否出现**新的阳明、少阳或其它证候**。
- **针足阳明**：古人截断传经的一种思路，临床核心仍是**当前脉证是否转变**。

要点总结

第8条讨论太阳病**自愈与再传**。

再传判断：看是否出现**新的证候方向**。

临床重点仍是**看脉证，不按日数硬套**。

胡希恕讲解

胡希恕老师不会把第8条理解成太阳病一定七日传完。**头痛至七日以上自愈**，说明部分太阳病可随着正气恢复而自行解除。

“欲作再经”只是提示病势可能继续变化，要看有没有新的证候出现。

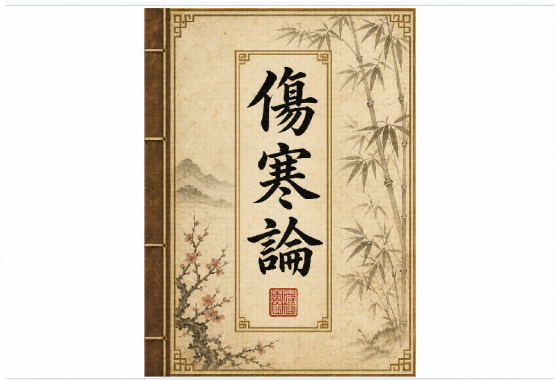
本条的临床意义是：轻证可观察，变化则随证处理；所谓针足阳明，也不能离开**当前脉证**。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第8条为**降两字格**，标三级，延续前面关于传经、病程的讨论。

“头痛至七日以上自愈”说明太阳病并非一定越来越重；“欲作再经”才提示要注意下一步变化。

学习时要防止把传经当固定程序，真正有用的是**观察病势，看证候是否转向**。



第9条

3 太阳病，欲解时，从巳至未上。

词语解析

- **欲解时**：指病势将要解除、症状有缓解趋势的时间段，不是固定处方依据。
- **巳至未上**：约上午九点到下午三点，阳气较盛，古人观察到太阳病较易**趋于缓解**。
- **如何判断欲解**：应看**恶寒减、脉转和、汗出得当、精神转佳**等实际变化。
- **临床看法**：时辰只作辅助参考，真正依据仍是**证候是否转解**。

要点总结

第9条讲太阳病欲解时。

判断欲解要看恶寒减、脉转和、精神转佳。

不可拘泥时辰，仍以实际脉证为准。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲“欲解时”，多作病势观察参考，不把它当成决定治疗的核心。太阳病欲解从巳至未，是说阳气较盛时病势容易缓解。

但病是否真要解，仍要看**恶寒是否减轻、脉是否和缓、汗出是否得当、全身状态是否转佳**。

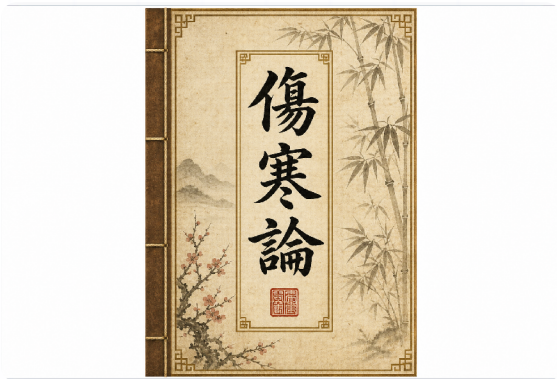
所以本条能帮助观察病程，却不能代替方证辨证。可靠的是**证候转和、病人自觉改善**。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第9条为**降两字格**，标三级。它是太阳病欲解时间的说明，不是主干方证条文。

“从巳至未上”大致是上午到下午阳气旺的时间段，古人借此说明太阳病有趋解的时机。

学习时可记其意，不必拘其时；要放在病势观察中用，**时辰只是辅助，脉证才是依据**。



第10条

3 风家表解，而不了了者，十二日愈。

词语解析

- **风家**：表虚经常容易感冒体质。
- **表解**：表证已经解除，恶寒发热等表证主矛盾不在，**不宜再强行解表**。
- **不了了**：表解后仍有轻微不爽、不清利、余证未尽，并非大病未解。
- **十二日愈**：提示恢复需要过程，轻微余证可待其自复，避免**过度发汗**、**过度攻伐**。

要点总结

第10条讲太阳中风表解后的恢复。

处理原则：余证轻微可观察，避免过治。

尤其要防止表已解而反复发汗。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲“风家”，常联系太阳中风、表虚有汗一类。表解以后还有“不了了”，多是余邪未尽或正气未复，不一定需要再大发汗。
“十二日愈”提示病后恢复有过程。若表证已解，只剩轻微不爽，就要避免过度治疗，尤其不能把余证当成表邪未解而反复发汗。
本条精神是：**表解后看余证轻重，轻者可待其自复**。治疗不是越多越好，关键是不 要扰乱恢复。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第10条为**降两字格**，标三级，讲的是风家表解后的余证恢复。
“不了了”不是大病未解，而是表证已去、身体还没完全清爽。若误以为还要继续强发汗，反而可能伤津伤正。
学习本条要抓住：**表解以后，不要见一点不爽就继续攻表**。观察恢复过程，也是辨证的一部分。



第11条

2 病人身大热，反欲得衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。

词语解析

- 身大热，反欲得衣：“反”是辨证眼目：体表虽显大热，患者却喜暖欲覆衣，提示本质偏寒，不可见热便清热。
- 热在皮肤，寒在骨髓：古人用“皮肤、骨髓”说明外在表现与内在本质相反，可理解为真寒外现假热。
- 身大寒，反不欲近衣：体表虽显大寒，患者却恶热、拒衣被，提示本质偏热，不可见寒便温补。
- 辨寒热真假：不能只凭体温或触诊冷热，要合看欲衣或欲去衣、口渴喜冷喜热、二便、精神与脉象。

要点总结

第11条讲寒热真假，两个“反”字是辨证眼目。

真寒假热抓手：身大热，反欲得衣。

真热假寒抓手：身大寒，反不欲近衣。

判断边界：重视患者真实欲求，并合参口渴、二便、精神与脉象，不可只凭体温和触诊冷热。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲本条，重点不在“皮肤、骨髓”的字面位置，而在辨寒热真假。身体摸着大热，患者反而想加衣被，说明外面虽热，内里却有寒；身体看似大寒，患者反而不愿近衣，说明外面虽寒，内里却有热。

临床判断不能只靠体温和手摸冷热，还要看病人的真实欲求：喜温还是喜冷、欲衣还是欲去衣、口渴与饮水、二便、脉象和精神状态。

本条最重要的警示是：假象与本质相反时，若寒热误判，治法也会完全相反。这里只提出辨证原则，不能脱离全身证候，机械地把某一个表现直接等同于真寒或真热。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲本条不是太阳病的主干条文，而是一条辨别寒热真假的重要提示。两个“反”字是全文眼目：身大热却反欲得衣，身大寒却反不欲近衣。病人的主观寒热趋向，与外在所见相反，正是在提醒我们不能被表象牵着走。

学习时还要把边界记清：欲衣、不欲近衣是重要证据，但仍须与口渴、饮食、二便、脉证等合参；不能只凭一处冷热就下真寒假热或真热假寒的结论。



第12条

1 太阳中风，脉阳浮而阴弱，啻啻恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

词语解析

- **太阳中风**：承接第2条，指**发热、汗出、恶风、脉缓弱**的阳性表虚证，不是现代医学的脑卒中。
- **脉阳浮而阴弱**：“阳、阴”在这里指取脉的浮沉：**轻取浮，重按弱**；提示病在表而津液已有外泄。
- **啻啻恶寒，淅淅恶风**：“啻啻”形容怕冷而收缩，“淅淅”形容**稍受风便觉寒冷不适**，突出表虚恶风。
- **翕翕发热**：形容热势**如羽毛覆盖般温温而发**，与表虚、汗出不畅快相应。
- **鼻鸣干呕**：鼻鸣为鼻窍不利；干呕为**气上冲、胃气不和**，都是桂枝汤证可见兼症。
- **桂枝汤主之**：方证核心是**阳性表虚：汗出、恶风、脉浮弱**；不是凡见头痛发热皆用桂枝汤。

要点总结

第12条是桂枝汤证主干条文。

脉象：**轻取浮，重按弱**。

核心抓手：**发热、汗出、恶风、脉浮弱**；**鼻鸣、干呕**为兼症。

病理：**阳性表虚**。

用方边界：**无汗、脉紧、身痛重者，应与麻黄汤证区别**。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第12条，是把第2条太阳中风进一步落实到桂枝汤方证。所谓“脉阳浮而阴弱”，不是寸脉浮、尺脉弱，而是**轻取见浮，重按则弱**：病在表，所以浮；汗出伤津、脉内不充，所以按之弱。

啻啻恶寒、淅淅恶风、翕翕发热，都是对表虚证寒热状态的细写。**鼻鸣**说明鼻窍不利，**干呕**则是气上冲、胃气不和。

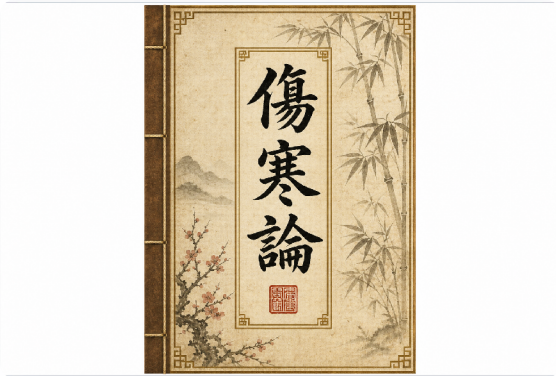
胡老辨桂枝汤，核心不是病名，也不是单见发热，而是**阳性表证兼汗出、恶风、脉浮弱**。与麻黄汤证相比，桂枝汤证表虚有汗，麻黄汤证表实无汗、脉紧、身痛较重。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第12条为桂枝汤证的主干条文。“太阳中风”已承接第1、2条，本条再把脉象、寒热和兼症写细。

“阳浮而阴弱”的阳、阴，是**浮取与沉取**的相对概念；“啻啻、淅淅、翕翕”则分别描写恶寒、恶风、发热的状态，不能只当作几个生僻词背诵。

本条归纳为**阳性表虚证**最合适：既有病在表的脉浮、发热、恶寒，又有汗出后津液偏少、脉按之弱的虚象。鼻鸣、干呕是常见兼症，**汗出、恶风、脉浮弱才是辨方主轴**。



第13条

1 太阳病，头痛发热，汗出恶风者，桂枝汤主之。

词语解析

- **头痛发热**：说明病在太阳之表，但这两项**并非桂枝汤独有**，麻黄汤等太阳病方证也可出现。
- **汗出恶风**：是本条最关键的辨方抓手：**汗已出而表不解，腠理疏、遇风更不适**，指向表虚。
- **桂枝汤主之**：以**头痛发热 + 汗出恶风**组成简明方证；有是证用是方，不拘现代病名。
- **与第12条关系**：第12条详述脉证兼症，本条压缩成临床提纲；二条共同突出**阳性表虚有汗**。

要点总结

第13条是桂枝汤证简明提纲。

强关联症状：**表证**：头痛、发热、头项强痛；**表虚证**：汗出、恶风、脉浮缓/浮弱。

特征性证：**汗出、恶风、鼻鸣、干呕、口不渴**。

类方边界：**有汗恶风偏桂枝汤；无汗脉紧、身痛重偏麻黄汤**。

胡希恕讲解

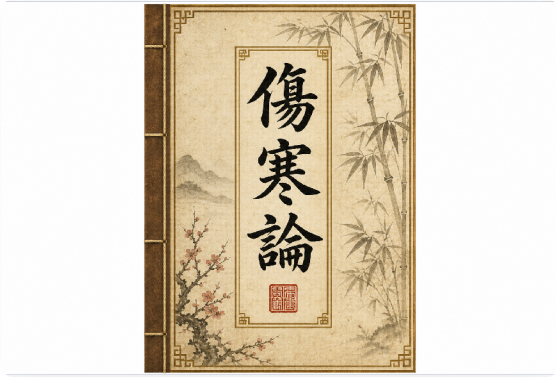
胡希恕老师讲第13条，是桂枝汤证最简明的一条。**头痛、发热**说明太阳表证，**汗出、恶风**才把它落实到桂枝汤的表虚一路。

头痛发热并不是桂枝汤专有，麻黄汤等太阳病也可以出现；若只抓头痛发热而忽略汗出恶风，就容易误用。这里的汗不是已经把病邪解除，而是**虽汗出，表证仍在**。临床要把本条与第12条合读：第12条详述脉浮弱、恶寒恶风、鼻鸣干呕；第13条则提炼为**头痛发热，汗出恶风**，便于快速抓住方证。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲本条主眼在**汗出恶风**。头痛、发热只说明表证，尚不能单独决定用桂枝汤；有汗而恶风，才显示表虚、津液外泄而病仍未解。

辨方时要与麻黄汤证对读：**桂枝汤证有汗、恶风、脉偏弱；麻黄汤证无汗、恶寒、脉紧、身痛较重**。所以本条既是桂枝汤速记条，也是防止只凭病名或单一症状用方的边界条文。



第14条

① 太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。

词语解析

- 项背强几几：“几几”形容项背拘急、俯仰转侧不利；是本方在桂枝汤证之外新增的主症。
- 反汗出恶风：“反”提示项背强常易使人想到表实无汗，但本条却汗出、恶风，所以仍属桂枝汤表虚一路。
- 桂枝加葛根汤：在桂枝汤证基础上加葛根，以解肌、升津、舒缓项背拘急。
- 与桂枝汤区别：二者都有汗出恶风；若项背强几几突出，则由桂枝汤进到桂枝加葛根汤。
- 与葛根汤区别：共同点是项背强几几；有汗恶风、脉偏弱偏桂枝加葛根汤，无汗恶寒、脉紧偏葛根汤。

要点总结

第14条是桂枝汤证兼项背强几几。

强关联症状：表虚证：汗出、恶风、脉浮缓；表证：发热、头痛、项背强几几。

特征性症状：桂枝汤证基础+项背部肌肉拘急，运转不自如。

与桂枝汤区别：项背强几几突出。

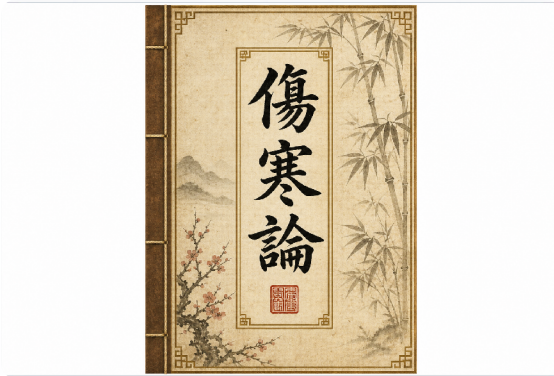
与葛根汤区别：有汗恶风偏桂枝加葛根汤；无汗恶寒、脉紧偏葛根汤。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第14条，是桂枝汤证再加项背强几几。汗出、恶风说明仍是阳性表虚证；项背拘急则提示津液不能充分输布到项背，所以在桂枝汤基础上加葛根。葛根既能解肌，又能升津液、舒缓项背。因而本方不是见颈项疼痛使用，而要先有桂枝汤证的底盘，再见项背强几几这一突出症状。本条必须与葛根汤证区别：两方都可见项背强，关键看表之虚实。汗出恶风、脉偏弱者偏桂枝加葛根汤；无汗、恶寒、脉紧者偏葛根汤。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第14条仍在桂枝汤证系统内，只是多了项背强几几。“反”字仍是辨方眼目：项背强几几容易让人联想到表闭无汗，但患者偏偏汗出恶风，说明不能转到麻黄、葛根汤的表实方向，而应在桂枝汤上加葛根。学习时可用一条递进线索记忆：第12条详述桂枝汤证 → 第13条简化桂枝汤证 → 第14条桂枝汤证加项背强几几。临床抓手不是单一颈项强，而是项背强几几 + 汗出恶风。



第15条

- 1 太阳病下之后，其气上冲者，可与桂枝汤。
- 2 若不上冲者，不可与之。

词语解析

- 太阳病下之后：太阳病本应从表解，却误用下法；误下可损伤里气，并使原有方证发生变化。
- 其气上冲：指病人仍有气从下向上冲逆、正气欲从表解的反应，提示表证尚未完全罢去。
- 可与桂枝汤：“可与”不是见气上冲便必用，而是还要确认汗出、恶风、脉浮弱等桂枝汤证仍在。
- 若不上冲者，不可与之：若向上、向表的趋势已消失，说明证候已经转变，必须重新察脉辨证，不可沿用原方。

要点总结

- 第15条讲太阳病误下后，桂枝汤能否继续使用。
- 可用线索：气上冲，且桂枝汤证仍在。
- 用方边界：气不上冲、表证已变，不可沿用桂枝汤。
- 核心原则：“可与”不是“必与”，仍须脉证合参。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第15条，太阳病本不当下，误下以后要看病势是否仍在表。其气上冲，说明人体仍有向上、向外抗邪的趋势，表证还没有完全解除，所以仍有使用桂枝汤的机会。

这里说“可与”，不是说凡见气上冲都固定用桂枝汤，更不是因为误下后必须用桂枝汤补救；还要合看汗出、恶风、脉浮弱等桂枝汤证。

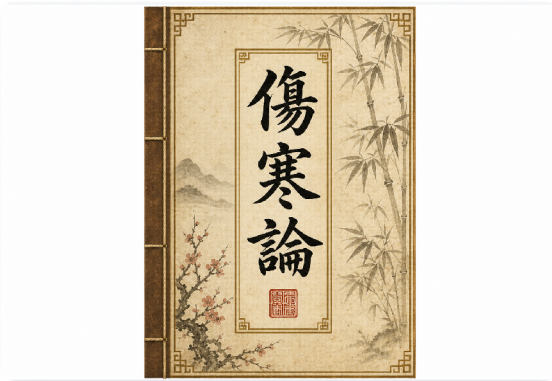
若不上冲，说明原来的向表趋势已经改变，就不能再守着原方。临床精神是：误治之后只认当前方证，不按原病名和既往处方继续治疗。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第15条主旨是太阳病误下以后，如何判断桂枝汤还能不能用。

“气上冲”可理解为人体仍保持从表解除疾病的动能，但其表现形式并不单一，也不是桂枝汤的专属症状。因此必须把“其气上冲”与表证仍在、桂枝汤证仍在合起来判断。

“若不上冲者，不可与之”把边界说得很清楚：证已变，方也必须变。本条正好为第16条“观其脉证，随证治之”作铺垫。



第16条

- 1 太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病。
- 2 桂枝不中与之也，观其脉证，知犯何逆，随证治之。

词语解析

- 汗、吐、下、温针：接连使用不合适的治法
- 坏病：被错误治疗扰乱、已经发生变证的疾病，不是“无法治疗”。
- 桂枝不中与之： “不中”即不合适：当前已不是桂枝汤证，不能把桂枝汤当作误治后的通用补救方。
- 观其脉证：先重新收集当前症状和脉象，判断表里、阴阳、寒热、虚实以及水血气。
- 知犯何逆：判断误治造成了哪一种病理变化。
- 随证治之：最后只依据眼前形成的证候选方，做到证变方变，有是证用是方。

要点总结

- 第16条是误治坏病的处理总纲。
- 坏病含义：原证被误治破坏，已不能照旧证、旧方处理。
- 辨治顺序：观其脉证 → 知犯何逆 → 随证治之。
- 重要边界：“桂枝不中与”是当前不对证，并非永远禁用桂枝汤。

胡希恕讲解

胡希恕老师特别重视第16条。病人经过不适当的汗、吐、下、温针以后仍不解，原来的证候结构已被破坏，形成所谓坏病，此时不能再死守最初的太阳病或桂枝汤。“桂枝不中与之”只是说明眼前已无桂枝汤证，并不是宣布误治后永远禁用桂枝汤。若以后重新出现相应方证，仍然可以依法选用。

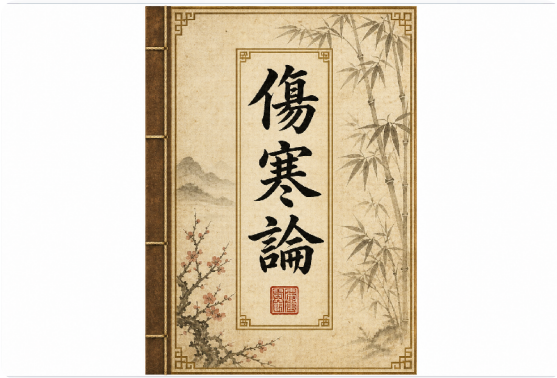
处理坏病要按顺序来：先观当前脉证，再判断此前犯了什么误治、造成什么变证，最后随证选方。关键是重新辨表里、阴阳、寒热、虚实，不被原诊断和旧处方束缚。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第16条应分层理解：前段说明汗、吐、下、温针误治后形成坏病；后段提出处理坏病的总原则。

“坏”不是病人无方可治，而是原来的证被治乱了，不能再按旧证套方。“知犯何逆”要求医生结合治疗经过，判断误汗、误下等究竟造成了津伤、阳伤、里虚还是其它变化。

本条是经方辨证的纲领之一：观其脉证 → 知犯何逆 → 随证治之。它承接第15条“证变则不可与桂枝汤”，也为后面各种误治变证的具体条文建立总原则。



第17条

3 酒客病，不可与桂枝汤，得汤则呕，以酒客不喜甘故也。

词语解析

- **酒客病**：指长期嗜酒者所患之病，常见**里热、湿热、胃气上逆**倾向；不能简单等同于“喝过酒的人”。
- **不可与桂枝汤**：本条警示酒客病多与桂枝汤甘温之性不合；重点是**先排除里热，再确认是否确有桂枝汤证**。
- **得汤则呕**：服后呕吐是药证不合的反馈，提示**甘温助热、胃气上逆**，不应把它当作正常排病反应。
- **酒客不喜甘**：并非只讲口味偏好，而是借“不喜甘”说明**病性与甘温滋腻药不相宜**。

要点总结

第17条讲桂枝汤在酒客病中的禁忌边界。

病理警示：**里热、湿热**。

误用反馈：**得汤则呕**，提示药证不合。

判断边界：**不是所有饮酒者绝对禁用，而是必须先辨里热与真实方证**。

醉酒后，头不清爽，四肢拘急，吐后，可以考虑**泽泻汤合小半夏汤加人参**的使用机会

胡希恕讲解

胡希恕老师讲“酒客病”，重点在酒客多有**里热、湿热和胃气上逆**，与桂枝汤甘温解肌的药性往往不相合。若误给桂枝汤，甘温助热、气逆于上，便容易呕吐。本条不是说凡有饮酒史者终身禁用桂枝汤，而是警告不能只见发热、恶风便套方。必须确认有没有真正的**汗出、恶风、脉浮弱等桂枝汤证**，并排除明显里热。“得汤则呕”应看作药证不合的危险反馈，**服后即呕不可解释成正常排病，更不可硬续原方**。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第17条为桂枝汤的禁忌与边界条文，不是桂枝汤主证。“酒客”不是偶尔饮酒，而是长期嗜酒、已经形成特定病理倾向的人。其常见的里热、湿热和胃逆，与桂枝汤的甘温性质相冲突，所以会出现“得汤则呕”。学习时不能把“不喜甘”只解释成个人口味，也不能把禁忌绝对化。真正要记住的是：**桂枝汤有明显里热者慎禁；药后呕吐提示必须立即重新辨证**。



第18条

2 喘家，作桂枝汤，加厚朴杏子佳。

词语解析

- 喘家：指素有久喘、反复咳喘的人；不是这次临时偶尔喘一下。
- 作桂枝汤：前提仍是汗出、恶风、脉浮弱等桂枝汤证，并非单凭喘症决定处方。
- 加厚朴杏子：厚朴降气除满，杏仁降肺气平喘，用于桂枝汤证兼咳喘、气逆或胸满。

要点总结

第18条讲桂枝汤证兼喘的加味法。

适用前提：先有桂枝汤证。

兼证抓手：素有久喘，外感后喘作或加重。

加味作用：厚朴降气除满，杏仁降肺平喘。

类方边界：里热喘、寒饮喘、表实喘均须另辨，不能见喘即用。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第18条，“喘家”是平素就有喘疾的人。这样的人再患桂枝汤证，外感会使原有喘症发作或加重，所以在桂枝汤中加入厚朴、杏仁。厚朴下气除满，杏仁降肺气平喘；但处方基础仍是头痛发热、汗出恶风、脉浮缓弱等桂枝汤证。不是见喘便使用桂枝加厚朴杏子汤。若汗出而喘兼明显里热，应想到麻杏石甘汤；无汗、脉紧、表实而喘，则另属麻黄汤方向。临床关键是先辨主方证，再处理兼喘。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第18条在《康平本》中为降一字格，标二级，并与第19条连在同一条中；《宋本》才分为第18、19两条。“喘家”强调素有旧疾。患者此次必须先形成桂枝汤证，喘只是超过桂枝汤原方治疗范围的兼证，才加厚朴、杏仁处理。本条体现经方加减的基本方法：方证为本，兼证加味。若喘的主因是里热、寒饮或表实，就不能因为“喘家”二字仍守桂枝汤系统。



第19条

2 又服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。

词语解析

- 又服桂枝汤吐者：不是理想药效，而是重要的误治信号。
- 其后必吐脓血：强调继续误治的严重风险；不是说每个服后呕吐者都一定吐脓血。
- 与第17条关系：第17条说酒客得汤则呕，本条进一步指出有里热者误服桂枝汤可能造成更重后果。
- 临床处理：若服后明显呕吐，应立即停审原方，重新辨寒热，不可强行续服。

要点总结

- 第19条讲桂枝汤误投里热的严重风险。
- 危险信号：服桂枝汤后即吐。
- 处理原则：立即停审原方，重新辨寒热，不可硬续。
- 条文边界：“必”重在强调高风险，不宜机械理解为人人必然发生。

胡希恕讲解

胡希恕老师把第19条看作重要警戒：里热者误服桂枝汤容易呕吐。桂枝汤甘温，又有发汗作用，会进一步伤津助热；热壅于上、损伤肺胃血络，久则可能形成吐脓血等严重后果。

服后吐并不是桂枝汤应有的正常反应，而是方药与病机不合的信号。尤其兼见口渴、烦热、舌红、脉数等里热表现，更不可强行续服。

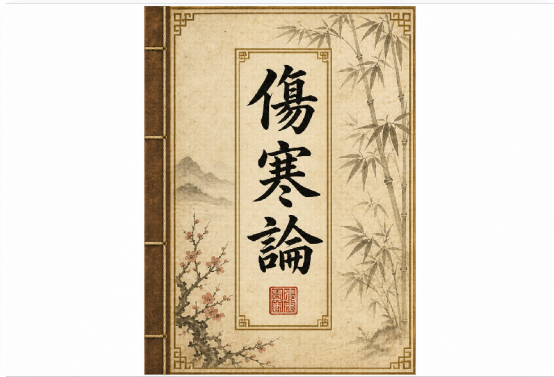
本条不必机械理解为每个呕吐者日后必吐脓血，而要抓住警示意义：甘温误投里热，可能助热伤津、伤血成脓。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第18、19条在《康平本》中原为同一条降一字格内容，《宋本》拆成两条，并把“又”改作“凡”。

“又”更像“另外再说一种情况”，不是承接喘家服药后必然发生。服桂枝汤即吐，反映胃气上逆或内有热，说明桂枝汤并不对证。

“其后必吐脓血”带有临床经验式的强烈警告，“必”可理解为可能性很大，不宜机械绝对化。核心边界是：有里热而服桂枝汤吐者，须立即停止并重新辨证。



第20条

1 太阳病，发汗遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。

词语解析

- 发汗遂漏不止：不是短暂出一场汗，而是汗液持续外泄，提示体表固摄失控。
- 恶风：原有表证可能未解，同时汗漏使表更虚。
- 小便难：大量津液从汗而失，体内可供排尿的水分不足，形成津伤而小便少涩，不等同于单纯水停。
- 四肢微急，难以屈伸：津液不足，肌肉筋脉失养，出现拘急。
- 加附子：仅用桂枝汤已不足以覆盖机能沉衰、偏阴寒的状态；加入附子取其温阳、振奋沉衰机能之意。
- 用方边界：不是普通自汗或四肢拘急都用；必须抓住误汗后汗漏不止 + 恶风 + 津阳受伤这一病程链。

要点总结

- 第20条是误汗后桂枝加附子汤证。
- 形成过程：表虚证误用强发汗 → 汗漏不止 → 机能沉衰，津液俱伤。
- 核心抓手：汗漏不止、恶风、小便难、四肢微急难以屈伸。
- 附子：配合干姜治疗里之沉衰，配合麻黄桂枝治疗表之沉衰。
- 本方证：靠桂枝汤的力量把附子带到皮肤表面，能发挥固表的作用。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第20条，条文暗含的是桂枝汤证误用麻黄汤一类强发汗法。本来表虚有汗，再被强发其汗，遂至汗漏不止，既亡津液，也伤阳气，病由阳性表虚进一步陷入机能沉衰。

恶风说明表仍未解而卫外更虚；小便难是汗出太过、津液被夺；四肢微急、难以屈伸，是组织失润、筋脉拘挛。

所以桂枝加附子汤不只是“止汗方”。桂枝汤仍解表、调和营卫，附子则振奋沉衰机能、温扶表阳。核心方证是误汗后汗漏不止，兼恶风、小便难、四肢拘急。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第20条为第16条坏病原则之后的具体示范：误汗造成新证，就按新形成的方证治疗。

“遂”字带有因果和警示意味，说明发汗方法不当；随后出现的恶风、小便难、四肢微急、难以屈伸，构成阳气受损与津液亏失并见的证据链。

本方是在桂枝汤证底盘上加附子，不可只凭汗多或肢体拘急套用。要抓住误汗一汗漏不止一表虚阳伤一津伤筋急的完整过程，也由此反证发汗必须以微似汗为度。